

УДК:616.329+/.33-072.1

А.И.Тажеудинов

ГГКП «Региональный диагностический центр», г. Алматы, РК

Патологии пищевода, желудка и 12-перстной кишки, выявленные при эзофагогастродуоденоскопии

Аннотация. Анализ результатов исследований, проведенных за 2009-2011 гг. показал, что воспалительные процессы верхнего отдела ЖКТ встречаются значительно чаще, чем другие виды патологии. В рамках реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы (№ 366 от 29.03.2012) ожидается повышение количества эндоскопических исследований. В этом плане для верификации результатов эндоскопии необходимо увеличить количество исследований с взятием мазков и биопсионного материала.

Ключевые слова: эндоскопическая диагностика, пищевод, желудок, 12-перстная кишка.

Актуальность

В стадии реформирования здравоохранения Казахстана, в ежедневном потоке пациентов, структура нозологических форм среди выявляемых патологий может измениться. В специализированных диагностических центрах некоторые частые патологии могут иметь доминирующее значение в принятии диагностического решения, чем более редкие формы патологий при сходстве некоторых ведущих признаков. Появление новых, довольно мощных частных диагностических клиник, также может повлиять на структуру патологий, с которыми обращаются в профильные госучреждения. Среди эндоскопических исследований эзофагогастродуоденоскопия занимает первое место. Анализ частоты патологии и признаков заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта всегда актуален.

Цель работы

- анализ структуры выполненных эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) за 2009-2011 годы.

Материалы и методы

В таблице 1 приведена структура обращений пациентов по годам. Всего за 2009 год было проведено 3536 эзофагогастродуоденоскопий, в 2010 году - 3602 и в 2011 году - 2998 исследований. Среди обследованных пациентов впервые обратилось 9744 (96,13%) и повторно - 392 (3,87%) пациентов, из них взрослых - 9166 (90,43%) и детей - 970 (9,57%). В распределении по годам, заметного разброса этих показателей не видно, за исключением детей в 2010 году.

Таблица 1 - Эндоскопические исследования, проведенные за три года

№	Пациенты	2009	2010	2011	Показатели 2009-2011		
					Абс.	%	Всего
1	Первичные	3536	3602	2998	9744	96,13	10136
2	Повторные	178	89	125	392	3,87	100%
3	Взрослые	3340	2875	2951	9166	90,43	10136
4	Дети	196	727	47	970	9,57	100%

Таблица 2 - Виды эндоскопических исследований за 2009-11 гг.

Виды исследования	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
				Абс.	%-
Эзофагогастро-дуоденоскопия	3515	3573	2984	10072	94,37
Колоноскопия	18	29	14	61	0,57
Сигмоскопия	-	9	1	10	0,09
Всего	3533	3611	2999	10143	100

Повторных исследований значительно меньше, чем первичных. После установления диагноза, многие пациенты наблюдаются по месту жительства или проходят лечение в специализированных клиниках.

Только в отдельных случаях по личной инициативе пациенты в динамике проходят контрольное эндоскопическое обследование.

Общеизвестно, что эзофагогастродуоденоскопия проводится чаще у взрослых, чем у детей. Тем не менее, необходимо больше работать педиатрам и детским гастроэнтерологами для снижения запущенных патологий у детей.

Виды эндоскопических исследований приведены в таблице 2.

Эзофагогастродуоденоскопия является основным доступным методом в визуальной диагностике заболеваний верхнего этажа ЖКТ. Эзофагогастродуоденоскопия у 10072 пациентов составляет 94,37% всех эндоскопических исследований ЖКТ. Колоноскопия, сигмоскопия, взятие биопсионного материала для гистологии или мазка для цитологии, в сумме составляют всего 5,63% всех эндоскопических исследований ЖКТ.

Заболевания пищевода, выявленные при эзофагоскопии, приведены в таблице 3.

Наиболее часто встречается патология пищевода - это эзофагиты у 2852 (75,23%) и эрозивно-язвенные эзофагиты у 209 больных. Дивертикулы выявлены у 16 (0,42%), грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) - у 64

Таблица 3 - Структура заболеваний пищевода, выявленных при эзофагоскопии

№	Патологии	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
					Абс.	%
1	Эзофагиты	1083	897	872	2852	75,23
	в том числе эрозивные и эрозивно-язвенные эзофагиты	95	41	73	209	
2	Доброкачественные образования	11	3	2	16	0,42
3	Злокачественные опухоли	17	9	16	42	1,11
4	ГПОД	33	15	16	64	1,69
5	ВРВП	18	12	18	48	1,27
	Общее	1162	936	924	3022	100

Таблица 4 - Структура заболеваний желудка, выявленных при гастроскопии

Патологии	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
				Абс.	%
Гастриты из них:	3509	3573	2750	9832	94,67
а) атрофические	1514	1476	1199	4189	40,33
б) поверхностные	1612	1784	1262	4658	44,86
в) гипертрофические	11	13	4	28	0,27
г) эрозивные	372	300	285	957	9,21
Эрозия желудка	56	78	61	195	1,88
Язва желудка	35	9	38	82	0,79
Гастрит оперированного желудка	31	27	29	87	0,84
Пилоростеноз	2	-	-	2	0,02
Доброкачественные опухоли	45	20	29	92	0,89
Злокачественные опухоли	34	18	42	96	0,91
Общее	3712	3725	2949	10386	100

Таблица 5 - Структура и выявляемость заболеваний 12-перстной кишки

№	Патологии	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
					Абс.	%
	Дуодениты в т. ч.	2927	2610	1967	7504	72,47
	эрозивные	541	379	472	1242	
2	Язва луковицы	413	310	391	1114	10,76
3	Рубцовая деформация луковицы	621	469	646	1736	16,77
	Общее	3961	3389	3004	10354	100

(16,6%) - эрозивные. Язва луковицы 12-перстной киш- луковицы - 1736 (16,77%) больных. ки выявлены у 1114 (10,76%) и рубцовая деформация

(1,69%) и варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) - у 48 (1,27%). У 42 (1,11%) больных гистологически подтверждена злокачественная опухоль пищевода. При такой низкой частоте в общем потоке неопухолевых патологий вероятность просмотра злокачественной опухоли пищевода слишком высока. Следовательно, при любой патологии, в первую очередь, необходимо исключить злокачественную опухоль пищевода. Взятие биопсионного

материала для гистологии, особенно мазка для цитологии, необходимо увеличить с 5 до 10% всех исследований пищевода. Такое расширение эндоскопического показателя к верификации диагноза является основой онкологической настороженности в эндоскопии.

Патологии желудка, установленные при гастроскопии, приведены в таблице 4, где гастриты выявлены у большинства - 9832 (94,67%) больных. В том числе определены атрофический гастрит у 4189 (40,33%), поверхностный - у 4658 (44,86%), гипертрофический - у 28 (0,27%) и эрозивный - у 957 (9,21%) пациентов.

Выявляемость доброкачественных и злокачественных новообразований остается на прежнем уровне и относительно одинакова. Цитоморфологическая верификация составила 91%.

Учитывая высокую заболеваемость раком желудка в республике, необходимо расширить показание на взятие мазка и/или биопсионного материала при фиброгастроскопии.

Среди патологии 12-перстной кишки дуодениты уставлены у 7504 (72,4 7%) больных, из них у 1242

Заключение

Анализ результатов исследований, проведенных за 2009-2011 гг. показал, что эзофагогастродуоденоскопия проводится значительно чаще, чем другие методы эндоскопии желудочно-кишечного тракта. Первичных исследований намного больше, чем повторных. Дети реже проходят эндоскопию, чем взрослые. Из-за «дефицита» детских гастроэнтерологов, педиатрам необходимо больше уделять внимание к жалобам детей. Воспалительные процессы верхнего отдела ЖКТ встречаются значительно чаще, чем другие виды патологии. В сравнении с исследованиями прошлых лет [1, 2, 3, 4] в структуре патологий явных отклонений не выявлено. В рамках реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012 - 2016 годы, утвержденной Правительством (№ 366от: 29.03.2012) ожидается повышение количества эндоскопических исследований. В этом плане для верификации результатов эндоскопий необходимо увеличить количество исследований с взятием мазков и биопсионного материала.

Список литературы

1. Тажединов А.И., Дуйсенбеков Ж.С., Салханов Б.А. Априорная вероятность патологии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по результатам эзофагогастродуоденоскопии в условиях диагностического центра // В кн.: Организация и совершенствование диагностического процесса в новых экономических условиях. Сб. работ юбилейной научно-практической конференции ФРЛКЦ, посвященной 10-летию его деятельности.- Алматы, 1998.- С. 159-161.
2. Айсарова А.П., Жарихина Т.А., Кусакина Г.К. и др. Морфологические особенности рака желудка // Мат. международного конгресса «Современные достижения гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии»- Алматы, 2004.-С.80-81. А.И.Тажединов

Тұжырым

А.И.Тажединов

ГГКП «Аймақтық диагностика орталығы», Алматы қаласында РК

Өнештің ақауы, асқазан және он екі елі ішек, эзофагогастродуоденоскопиядан анықталуы.

2009-2011 жылдары жүргізілген зерттеудің нәтижелерін талдау, патологияның басқа түрлеріне караганда асқазанчик жолдарының жотарты белтіндеп асқинулар процеедәуір жиі кездесесетидтн керсетл. КР 2012-2016 жылдары онкологияның кемек кесету жобасын кке асыру барысында /№366 29.03.2012 ж/эндоскопиялық зерттеулер саны кебеймек. Оның Ынде жакналармен биопсия материалдарын алып жасалынатын, нәтижес верификациялантан эндоскопиялық зерттеулер саны есуі керек.

Түйінді сөздер: эндоскопиялық зерттеу, өнеш, асқазан, он екі елі ішек

Summary

A.I.Tazhedinov

GGKP «Regional Diagnostic Center», Almaty, Kazakhstan

Pathology of the esophagus, stomach and duodenum 12, revealed during esophagogastroduodenoscopy.

Analysis of the results of studies conducted over 2009-2011 showed that inflammation of the upper GI occur much more frequently than other types of pathology. In the framework of the Program of development of cancer care in the Republic of Kazakhstan for 2012-2016 (№ 366 from 29.03.2012) is expected to increase the number of endoscopic examinations. In this respect, for the verification of endoscopies necessary to increase the amount of research with smears and biopsy material.

Keywords: endoscopic examinations, esophagus, stomach, duodenum 12.